·临床监护·

精神障碍患者跌倒危险因素评估及早期干预

杨红艳

（四川省复员退伍军人医院，四川 成都 611236）

摘 要：目的 研究探讨精神障碍患者跌倒高危因素与早期临床护理干预方法。**方法** 将我院 2012 年 9 月至 2014 年 9 月收治的精神障碍患者 120 例为研究对象，采用住院患者跌倒高危因素评估与护理措施的表进行评估，并且实行标准化的护理干预措施。**结果** 检验结果发现，护理干预之前，患者跌倒评分超过 4 分总共有 23 例，器质性障碍 24 例。精神活性物质引发精神障碍的有 23 例，精神分裂症 20 例其他 6 例；而实施护理干预后跌倒评分高于 4 分的则为 62 例，器质性障碍 12 例。精神活性物质引发精神障碍的有 13 例，精神分裂症 17 例，其他 6 例。**结论** 分析后发现，认知障碍、依从性低与沟通障碍是影响精神障碍患者跌倒的主要因素，与此同同时，通过有效护理干预措施，能够预防跌倒伤的处理。

关键词： 精神障碍；跌倒；早期干预

中图分类号： R473.74 **文献标识码：** B DOI：10.3969/j.issn.1671-3141.2016.02.223

0 引言

可以说在患者治疗疾病的过程中，患者安全同样管理的重点内容。在过去，医院正常处理的过程中普遍将患者的安全放在首位。从文献记载中发现，每年医院发生不良事件跌倒的比例逐渐增多。在患者治疗疾病期间，对患者进行评估可有效减少患者的跌倒、坠床等事件。但是研究如何有效避免跌倒的发展，当亲临床跌倒的风险逐渐隐退。当然在随后的修掉。防范管理制度，精神障碍患者由于疾病的特殊性，可能存在行为紊乱、不配合等情况，我科根据医院要求采用全院统一的跌倒评估量表对患者进行评估，对高危患者立即进行标准化因素应当防范管理制度。精神障碍患者由于疾病的特殊性，可能存在行为紊乱、不配合等情况[1]。本文将我院 2012 年 9 月至 2014 年 9 月收治的精神障碍患者 120 例为研究对象。研究探讨精神障碍患者跌倒高危因素与早期临床护理干预方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料。将我院 2012 年 9 月至 2014 年 9 月收治的精神障碍患者 120 例为研究对象。其中男 86 例，女 34 例，患者年龄为 20~80 岁，平均年龄为（29.3 ± 3.7）岁。

1.2 方法。在所有患者入院后，护理人员对患者跌倒的高危因素进行估量，评估，根据患者存在的跌倒风险实行标准化的护理干预措施，干预措施主要包括常规护理与针对性的措施。

常规措施：护理人员向患者于家属关于预防跌倒进行安全教育，同时还应当保持病房内的干净整洁。护理人员应当特别注意将床旁走道的障碍物清除掉，将患者常用的药物放置在恰当位置，便于患者的放取。护理人员应当还有一项就是指导患者呼叫器的应用。

针对性护理措施：护理人员应当鼓励患者实行渐进活动，在有必要的情况下使用相关的辅助性工具。患者家属需要在旁边陪伴，在需要离开的时候应当告知值班护理人员，注意将轮椅与便盆座椅固定[2]。同时护理人员还应当指导患者使用便器，并且还应当使用床档保护与约束带保护。在每次的健康教育完成后，需要家属签字，通过家属签字的方式能够增强患者与家属的危险意识。为保证每天的护理，在患者的床头与腕带上做好标记，这样有助于指导护理人员做好指导与护理措施。保证每天交接班正常的运行。另外还需要加强跟踪评估，每周管理两个，直到风险因素解除。

1.3 统计学分析。本次实验操作中所产生的数据都经过 SPSS 17.0 的统计学处理。并且在处理数据的过程中采用 t 检验原理来对资料比进行分析，而资料笔中所产生的数据都统一的应用 χ^2 来检验，检验结果的数据 $P < 0.05$，就充分说明数据具有统计学意义。

2 结果

检验结果发现，护理干预之前，患者跌倒评分超过 4 分总共有 23 例，器质性障碍 24 例。精神活性物质引发精神障碍的有 23 例，精神分裂症 20 例其他 6 例；而实施护理干预后跌倒评分高于 4 分的则为 62 例，器质性障碍 12 例。精神活性物质引发精神障碍的有 13 例，精神分裂症 17 例，其他 6 例。

3 讨论

（下转第 289 页）

程中，若脐带绕颈较松时，医护人员可借助手将脐带沿着胎儿的肩部或头部顺推[5]，若脐带绕颈较紧时，医护人员可借助止血钳将其剪断等。

因此，在产妇进行脐带绕颈阴道试产时，应结合科学合理的护理措施，可降低新生儿发生窒息的概率，保障产妇及胎儿的安全。

参考文献

[1] 陈玉姝．脐带绕颈阴道试产的护理观察[J]．中国医药指南，2010.8(13):292-294.

[2] 王阿婷、李小会、郭君丽，等．专人陪护和心理疏导对胎儿脐带绕颈产妇分娩方式的影响[J]．贵阳中医学院学报，2014.36(2):119-120.

[3] 罗丽．头位脐带绕颈经阴道分娩的临床观察与护理[J]．全科护理，2010.08(16):1437-1438.

[4] 黄秀桃．头位脐带绕颈经阴道分娩可行性的临床观察及护理[J]．国际护理学杂志，2012.31(5):815-816.

[5] 金芙蓉、张玲、潘一红，等．头位妊娠脐带绕颈经阴道分娩的评估标准及效果研究[J]．中国农村卫生事业管理，2013.33(1):70-72.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

护理人员要帮助患者办理出院手续，患者出院后，要认真书写病例。

1.3 观察指标[3]。护理后，分析对比两组患者住院时间、住院费用以及健康知识掌握度等指标。其中，健康知识掌握度评定应用我院自制问卷调查表，主要包括 20 个问题，每道题 5 分，共 100 分，标准：优：80 分以上；良：61~80 分；差：60 分及以下。

1.4 统计学方法。使用 SPSS 20.0 统计学软件包对所有数据进行处理，计量资料使用均数 ± 标准差形式表示，构成率、比等两组间对比应用 χ^2 检验，独立样本进行 t 检验。以 $P<0.05$ 作为标准，差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者住院时间、住院费用对比。A 组住院时间短于 B 组，住院费用明显少于 B 组，对比（$P<0.05$），见表 1：

表 1 两组患者住院时间与住院费用对比

组别	例数	住院时间（d）	住院费用（元）
A 组	45	9.2±2.0	6524.2±522.4
B 组	43	14.8±5.5	8235.8±752.7
P	-	<0.05	<0.05

2.2 两组患者健康知识掌握度对比。A 组：30 例优，12 例良，3 例差，健康知识掌握优良率 93.3%；B 组：17 例优，12 例良，14 例差，健康知识掌握优良率 67.4%；A 组健康知识掌握度优良率明显高于 B 组（$P<0.05$）。

3 讨论

临床护理路径为一种全新的护理理念，坚持以人为本的护理理念，以患者为中心，为其制定完善、详细的护理计划，提高患者治疗依从性，使其积极参与到疾病治疗、护理过程中，能够极大调动患者积极参与性，并保障健康教育实施的有效性[4]。本组研究，B 组应用传统护理模式，A 组应用临床护理路径护理，结果显示，A 组住院时间短于 B 组，住院费用明显少于 B 组，A 组健康知识掌握度优良率明显高于 B 组，对比（$P<0.05$）。CNP 主要具备以下优势：（1）能够有效缩短患者住院时间，减少住院费用：对患者进行护理时，严格根据护理路径程序进行，能够减少繁琐的护理内容，缩短住院时间，本次研究结果 A 组住院时间（9.2±2.0）d 明显短于 B 组的（14.8±5.5）d；且进行护理过程中，能够避免患者由于病情变化、个人原因、检查结果延误等因素影响导致延长住院时间，增加治疗费用的情况，A 组住院费用（6524.2±522.4）元明显少于 B 组的（8235.8±752.7）元；（2）能够明显提高患者健康知识掌握度：应用 CNP 护理模式，护理人员严格根据时间、内容为患者实施系统性、规范性、严谨性以及动态性的教育，并定时评价和评估，使患者及时了解自身病情和护理目标，积极主动配合护理；护理人员通过对患者讲解疾病相关知识、用药方法、重要性等，提高患者健康知识掌握度。

综上所述，对短暂性脑缺血发作患者应用临床护理路径，能够明显缩短住院时间，减少住院费用，提高健康知识掌握度。

参考文献

[1] 张悦．临床护理路径应用于神经内科短暂性脑缺血发作患者的研究[J]．健康必读(中旬刊)，2013，12（3）：371-371．
[2] 吴艳华．临床护理路径在短暂性脑缺血发作患者中的应用[J]．中国实用神经疾病杂志，2012，15（11）：94-95．
[3] 刘霞，薛芬，甘晓峰．临床护理路径在短暂性脑缺血发作中的应用[J]．中国实用神经疾病杂志，2012，15（8）：85-86．
[4] 朱章丽．临床护理路径对短暂性脑缺血发作患者的疗效观察[J]．当代护士(下旬刊)，2015，01（6）：40-41．

（上接第 291 页）

研究分析精神障碍患者跌倒的原因，并根据产生的原因采取相应的护理干预措施。分析高危因素，具有重要的意义。

3.1 精神障碍患者跌倒的高危因素。精神障碍患者常常表现出认知功能较差，主要表现为对外界刺激敏感下降、记忆力衰退与运动协调等障碍[3]。在受到精神症状的不同影响，患者患病期间会出现兴奋、抗拒治疗与躁动不安。在患者服用精神类药物后会出现过度镇静、体位低血压等作用，患者在其中常常表现为初步状态稳定。研究人员在研究的过程中发现护理人员如果对患者跌倒的危险因素不够重视，缺乏专业化的护理，就会降低跌倒的依从性。精神障碍患者跌倒的高危因素，需要护理人员谨慎对待，并予以高度的重视，这样才能够避免跌倒事件的出现。引发患者跌倒的高危因素有多种，需要护理人员准确的评估，并采取有效的措施，这样才能够避免跌倒事件的发生。

3.2 正确评估、早期干预。从理论上而言，跌倒无论是否能避免，在平地与稍高的地方行走都会造成伤害。在实际中就会发现，年龄大、女性、服用抗精神病药物、服用苯二氮䓬类药物、上厕所可能是精神障碍患者跌倒损伤的危险因素。跌倒事件的发生，不但增加患者的痛苦，加重经济负担，也还可能引发医患纠纷。原卫生部将防范患者跌倒作为评价医院安全和护理质量的重要指标，各家医院积极探索评估方法，采取针对性措施，取得了较好的效果。从本次的研究现象就可以知道，识别精神障碍患者跌倒的风险，及早、规范的干预能有效减少跌倒事件的发生[4]。

综上所述，分析后发现，认知障碍、依从性低与沟通障碍是影响精神障碍患者跌倒的主要因素，与此同同时，通过有效护理干预措施，能够预防跌倒伤的处理。

参考文献

[1] 余春、李俊英、汤晖．实施优质护理服务对预防肿瘤患者跌倒的影响[J]．华西医学，2012，27(1)：97-98．
[2] 陶筱琴、端木欣荣、陈恬茵、等．精神科病人跌倒危险评估及早期护理干预的方法与效果[J]．护理管理杂志，2011，11(11)：821-822．
[3] 盛梅青、房圆、张盛宇、等．2003-2008 年住院精神障碍患者跌倒损伤原因分析[J]．上海医药，2012，33(1)：33-36．
[4] 吴琳娜、李芸、胡秀英、等．老年患者住院期间跌倒的危险因素分析及干预路径[J]．四川大学学报：医学版，2012，43(2)：222-225．

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net